Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

Esta pauta –de uso optativo- ha sido diseñada para facilitar a los profesionales que realizan los procesos de evaluación de NEE, en el marco del Decreto 170, la recogida de antecedentes de anamnesis relevantes del estudiante. Puede ser completada por uno o más profesionales en el proceso de detección y evaluación de las NEE que presenta el alumno(a) y de los apoyos que requiere para aprender y participar en el contexto escolar.

1. DENTIFICACIÓN DEL ESTUDIANTE

Nombre	Gaspar Antonio Miranda Barrera			Sexo	F ☐ M X
Fecha Nacimiento	24/02/2021	Edad actual	5 años meses	País natal:	Chile
Domicilio actual:	Torconal 397, casa 11.			Teléfono	954198245
Lengua materna	Español	Grado dominio	comprende ☒ habla ☒ lee ☐ escribe ☐		
Lengua de uso	Español	Grado dominio	comprende ☒ habla ☒ lee ☐ escribe ☐		
Escolaridad actual:	Kinder	Establecimiento	Liceo mixto, básico 1.		

2. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS INFORMANTES

1. Fecha de la entrevista: 11/03/2026	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: Alejandra Barrera Jiménez.	Nombre:
Relación con el/la estudiante: Mamá.	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):
3. Fecha de la entrevista:	4. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Relación con el/la estudiante:	Relación con el/la estudiante:
En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a)	En presencia de (miembro de la familia, intérprete, otro/a):

3. IDENTIFICACIÓN DEL O LOS ENTREVISTADORES

1. Fecha de la entrevista: 11/03/2026	2. Fecha de la entrevista:
Nombre: María Constanza Ogarrín	Nombre:
Rol/cargo: Ed. diferencial.	Rol/cargo:
3. Fecha de la entrevista:	3. Fecha de la entrevista:
Nombre:	Nombre:
Rol/cargo:	Rol/cargo:

1

4. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA O SITUACIÓN QUE MOTIVA LA ENTREVISTA

Posible ingreso a P.I.E.
Derivación por parte de la docente de sala.

5. ANTECEDENTES RELATIVOS AL DESARROLLO Y A LA SALUD DEL/LA ESTUDIANTE

¿El o la estudiante tiene algún diagnóstico previo? ☐ No ☒ Sí (especificar)

Pediatría:	Psicología:
Kinesiología:	Psiquiatría:
Genético:	Psicopedagogía:
Fonoaudiología: TEL.	Terapia Ocupacional:
Neurología:	Otro:

1

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.1. Primer año de vida

Tipo de parto: ☐ normal ☐ inducido ☐ fórceps ☑ cesárea (señalar motivo) No estaba en posición

Tuvo asistencia médica durante el parto? ☑ SI ☐ NO | Peso: 3,457 | Talla: 50.

Señale antecedentes relevantes del Embarazo y Parto:

El estudiante estaba sentado por ende fue cesárea.

Señale si durante los doce primeros meses de vida el niño o niña presentó:

Desnutrición	Si	~~No~~	Traumatismos	Si	~~No~~	Encefalitis	Si	~~No~~
Obesidad	Si	~~No~~	Intoxicación	Si	~~No~~	Meningitis	Si	~~No~~
Fiebre alta	Si	~~No~~	Enfermedad respiratoria	Si	~~No~~	Otra(s)		
Convulsiones	Si	~~No~~	Asma	Si	~~No~~			
Hospitalizaciones	Si	No ✓	Especifique motivos y duración:					

Se realizaron controles periódicos de salud | ~~Si~~ | No | Vacunas | ~~Si~~ | No

Observaciones:

Sin observaciones.

5.2. Desarrollo Sensorio Motriz

Edad en que el niño (a)

Fija la cabeza: 3 meses. | Se sienta sólo/a: 3 meses. | Camina sin apoyo: 3 años

Primeras palabras: 3 meses. | Primeras frases: 4 años | Se viste solo/a: - o -

Controla esfínter vesical Diurno: ✓ Nocturno: ✓ | Controla esfínter anal Diurno: ✓ Nocturno: ✓

Observaciones:

No gateo, se desplazaba sentado en el suelo.

En su actividad motora general se aprecia:

☐ normal ✓ activo ☐ hiperactivo ☐ hipoactivo

Su tono muscular general se aprecia:

☑ normal ☐ hipertónico ☐ hipotónico

En relación con su motricidad gruesa se aprecia:

Estabilidad al caminar	~~Si~~	No	Caídas frecuentes	Si	~~No~~	Dominancia lateral derecha	~~Si~~	No

En relación con su motricidad fina el niño (a) logra:

Garra	~~Si~~	No	Prensión	~~Si~~	No	Pinza	~~Si~~	No
Ensarta	~~Si~~	No	Dibuja	~~Si~~	No	Escribe	Si	~~No~~

En relación con algunos signos cognitivos el niño (a)

Reacciona a voces o caras familiares	~~Si~~	No	Manipula y Explora objetos	~~Si~~	No
Demanda objetos y compañía	~~Si~~	No	Comprende prohibiciones	~~Si~~	No
Sonríe, balbucea, grita, llora, indica o señala	~~Si~~	No	Posee evidente descoordinación ojo-mano	Si	~~No~~

Observaciones:

Sin observaciones.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LEY

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.3. Visión - Audición:					
Se interesa por los estímulos visuales (colores, formas, movimientos, etc.)	Sí	No	Se interesa por los estímulos auditivos (ruidos, voces, música, etc.)	Sí	No
En ocasiones tiene los ojos irritados o llorosos	Sí	No	Reacciona o reconoce voces o sonidos familiares	Sí	No
Presenta dolores frecuentes de cabeza	Sí	No	Gira la cabeza cuando se le llama o ante un ruido fuerte	Sí	No
Se acerca o aleja demasiado los objetos a la vista (frunce el ceño)	Sí	No	Acerca los oídos a la TV, radio o fuente de sonido.	Sí	No
Sigue con la vista el desplazamiento de los objetos o personas	Sí	No	En ocasiones se tapa o golpea los oídos	Sí	No
Presenta movimientos oculares "anormales"	Sí	No	Presenta frecuentes dolores de oídos	Sí	No
Manifiesta conductas "erróneas" (tropiezos, choques)	Sí	No	La pronunciación oral es adecuada	Sí	No
Presenta diagnóstico médico de miopía, estrabismo, astigmatismo, u otro.	Sí	No	Presenta diagnóstico médico de otitis crónica, hipoacusia u otra.	Sí	No

Observaciones:

Toda la familia presenta miopía y astigmatismo.

5.4. Desarrollo del Lenguaje					
El niño (a) se comunica preferentemente en forma					
☐ oral ☐ gestual ☑ mixto ☐ otro (especifique):					
Características del lenguaje expresivo					
Balbucea (oral o señas)/emite sonidos	Sí	No	Emite/produce frases	Sí	No
Vocaliza/realiza gestos o señas aisladas	Sí	No	Relata experiencias	Sí	No
Emite palabras/produce señas	Sí	No	La emisión/pronunciación/producción es clara	Sí	No
Características del lenguaje comprensivo					
Identifica objetos	Sí	No	Sigue instrucciones simples	Sí	No
Identifica personas	Sí	No	Sigue instrucciones complejas	Sí	No
Comprende conceptos abstractos	Sí	No	Sigue instrucciones grupales	Sí	No
Responde en forma coherente preguntas de la vida diaria	Sí	No	Comprende relatos, noticias, cuentos cortos	Sí	No
Manifestó pérdida del lenguaje oral (especifique edad y motivos): NO.					

Observaciones:

Relata experiencias pero no se comprende. No logra expresarse.

5.5. Desarrollo Social					
Se relaciona espontáneamente con las personas de su entorno natural.	Sí	No	Se relaciona en forma colaborativa	Sí	No
Explica razones de sus comportamientos y actitudes	Sí	No	Respeta normas sociales	Sí	No
Participa en actividades grupales	Sí	No	Respeta normas escolares	Sí	No
Opta por trabajo individual	Sí	No	Muestra sentido del humor	Sí	No
Presenta lenguaje ecolálico	Sí	No	Movimientos estereotipados	Sí	No
Exhibe dificultad para adaptarse a situaciones nuevas	Sí	No	Pataletas frecuentes	Sí	No
Ante los siguientes estímulos su reacción es:					
Luces: ☑ natural ☐ desmesurada	**Sonidos:** ☑ natural ☐ desmesurada		**Personas extrañas:** ☑ natural ☐ desmesurada		

Observaciones:

Sin observaciones.

LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE DOCUMENTO SON CONFIDENCIALES, SU DIVULGACIÓN O USO INDEBIDO ES PENADA POR LA LEY

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

5.6. Estado Actual de Salud del/la Estudiante

Vacunas al día	~~Sí~~	No	Trastorno motor	Sí	~~No~~
Epilepsia	Sí	~~No~~	Problema bronco-respiratorio	Sí	~~No~~
Problemas cardiacos	Sí	~~No~~	Enfermedad infecto-contagiosa	Sí	~~No~~
Paraplejia	Sí	~~No~~	Trastorno emocional	Sí	~~No~~
Pérdida auditiva	Sí	~~No~~	Trastorno conductual	Sí	~~No~~
Pérdida visual	Sí	~~No~~	Otro (especifique):		

El o los problemas de salud reciben control/tratamiento (especifique):

Alimentación: ☐ normal ☑ "malo/a" para comer ☐ "bueno/a" para comer ☐ Otro (especifique)

Peso (apreciación del informante): ☑ normal ☐ bajo peso ☐ obesidad

Sueño: ☑ normal ☐ tranquilo ☐ inquieto Horas que duerme: 9 - 10 horas.

☐ insomnio ☐ pesadillas ☐ terrores nocturnos
☐ sonambulismo ☑ despierta de buen humor

Duerme: ☑ solo ☐ acompañado
(Especifique):

Humor/comportamiento *(señale el comportamiento habitual)*

☑ alegre ☑ juguetón/bromista ☑ risueño(a) ☐ triste ☑ serio ☐ rebelde ☐ apático ☐ violento(a)
Otro:

Observaciones:

Desde 2026 duerme solo.

6. ANTECEDENTES FAMILIARES

Personas que viven con el niño o niña y/o que son que son responsables de su cuidado.

Nombre	Parentesco	Edad	Escolaridad	Ocupación actual
1. Carlos Miranda	Padre	40	Universit.	Ingeniero mec. industrial
2. Alejandra Barrera	Madre	39	Universit.	Dueña de casa.
3. Carlos Miranda	hermano	13		estudiante.
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				

Antecedentes de Salud de la Familia

(Señale aquellos antecedentes que son relevantes en función de la entrega de apoyos que requiere el o la estudiante):

Sin antecedentes.

Observaciones:

Ley 20.201 – Decreto 170/2009
Evaluación Diagnóstica Integral de Necesidades Educativas Especiales

ENTREVISTA A LA FAMILIA / ANAMNESIS

Síntesis de los antecedentes de salud, escolares y sociales del estudiante

7. ANTECEDENTES ESCOLARES Y APOYO DE LA FAMILIA

Trayectoria escolar					
Edad de ingreso al sistema escolar	6 meses	Asistió a jardín infantil		Sí ✓	No
Nº de colegios en que ha estudiado	2	Modalidad de enseñanza Regular ☒ Especial ☐ Técnica ☐:			
Motivo de los cambios: Traslado de ciudad.					
Ha repetido curso/s	Sí	No ✓	Curso(s)	Motivo:	

Situación actual											
Nivel/curso actual	Kínder		**Dificultad de aprendizaje**	Sí	No ✓	**Dificultad para participar**	Sí	No ✓	**Conducta disruptiva**	Sí	No ✓
Asiste regularmente	Sí ✓	No	Asiste con agrado	Sí ✓	No	Apoyo familiar en tareas	Sí ✓	No	Amigos (as)	Sí	No ✓

Actitud de la familia

¿Cómo evalúa la familia el desempeño escolar del estudiante?
☒ satisfactorio ☐ insatisfactorio (motivos) .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a las dificultades escolares del estudiante?
☒ apoyo ☐ castigo ☐ indiferencia ☐ compasión ☐ tensión ☐ otra .....

¿Cuál es la respuesta de la familia frente a los éxitos escolares del estudiante?
☒ apoyo ☐ indiferencia ☐ otra .....
Especifique el tipo de refuerzos o premios:
☐ expresiones afectivas ☒ alimentos preferidos ☐ ver TV ☒ juguetes tiempo libre ☐ otro(s).....

¿Quiénes apoyan el proceso de aprendizaje y desarrollo del estudiante?
☒ madre ☒ padre ☐ hermanos/as ☐ Otros familiares Otros profesionales .....

¿Qué expectativas muestra la familia frente al futuro escolar del estudiante?
☒ alta (incluye al grupo familiar) ☐ mediana (incluye sólo madre/padre) ☐ baja (no incluye a ningún miembro)

¿Ofrece la familia un ambiente físico y emocional adecuado para el aprendizaje?
☒ Ambos ☐ Sólo físico (espacios, materiales, ventilación, luminosidad) ☐ Sólo emocional (tranquilo, relajado, comprensivo)

Comentarios u otras observaciones relevantes que no se han registrado o explorado:

Estudiante presenta TEL, diagnosticado por pediatra el año 2025.

Cambio de ciudad de Calama a San Andres a principios del año 2026.

5